

WHO システム思考を、明日の外来でどう使うか

部品から繋がりへ — 1 人の患者から地域までのズームアウト

出典（主）



このセッションで持ち帰ってもらう 3 つ

1. WHO が 2026 年に提唱した 3 つのフレーム転換 と言える
2. 目の前の 1 人の患者で「部品の見方」と「繋がりの方」を切り替えられる
3. 自分の診療を、半径を広げて (チーム→外来→地域) 眺める 語彙 を持つ

約束： 今日の話は、研修 1 年目の人が明日の外来で 1 つだけ試せることから始めます。

後半に進むにつれて視野が広がりますが、置いていきません。最後まで一緒に旅をしましょう。

0. なぜ今この話？

- 2026 年 1 月、WHO と NHS England が共催ウェビナーで「保健医療人材の強化にはシステム思考が必要」と公式提唱
 - 背景：WHO 推計で 2030 年までに世界で 1,100 万人の保健医療人材が不足する見通し
 - 「人を増やす」だけでは解けない問題 → 認識のフレームそのものを変える必要がある、というのが今回の提言
 - 出典：WHO/AHPSR, *Systems thinking for health systems strengthening - changing the frame* (2026 年 2 月)

Part 1. 症例から入る

症例：65 歳男性、2 型糖尿病、HbA1c 8.6%

30 秒、隣の人と話してみてください。

- ・ 既往：高血圧、軽度 CKD(eGFR 52)
- ・ 内服：メトホルミン 1500mg/ 日、ARB
- ・ 半年前から HbA1c が 7.4 → 8.6 にじわじわ上昇
- ・ 外来では「ちゃんと飲んでます」「食事もう気をつけてます」と笑顔
- ・ 体重も変わらない
- ・ 次の一手は？

ありがちな「部品の見方」

「やるべきこと」のチェックリストはこなしている。けれど、何かが噛み合っていない感じがする。

- HbA1c が高い → 内服を強化する (SGLT2 阻害薬を追加？ GLP-1?)
- あるいは「服薬アドヒアランスが悪いのでは」と疑う
- 食事指導の紙を渡し直す
- 次回 3 か月後、また同じ会話

同じ患者を「繋がりの方」で見直す

外来カルテの欄外に書かれていない情報：
HbA1c の背後には、こういう繋がりがある。

- ・ 半年前に 妻が入院 して以来、夕食は近所のスーパーの惣菜に
- ・ 以前は妻が早朝散歩に付き合っていたが、今は 1 人だと億劫で出ない
- ・ 通院は本人の運転 → 最近運転に自信がなくなり、診察日を月 1 回に減らしたいと思っている
- ・ 息子家族は隣市だが、義母の介護で手一杯
- ・ 患者本人は「先生に余計な心配をかけたくない」と思っている

同じカルテ、違う問診

「最近、食事や生活で変わったことってありますか？」
たった 1 問。ただし、前のスライドの情報を引き出そうとして聞く。
返ってくるのは「いや、特に……」かもしれない。それでも：
繋がりを意識した問診は、技術というより " 視野 " の問題。

- ・ 「奥さん、元気にされてますか？」
- ・ 「散歩、続けてます？」
- ・ 「ここまで運転、しんどくないですか？」

Part 2. 概念整理

WHO/NHS England の3つのフレーム転換

	これまで（部品）	これから（繋がり）
1. 何を見るか	部品（parts）	繋がり（connections）
2. どう介入するか	処方（prescription）	学習（learning）
3. どう成果を測るか	アウトカム測定	文脈理解

出典：*Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame*,
WHO/AHPSR, 2026

転換 1: 部品から繋がりへ

「数値は嘘をつかないが、数値だけ見ていると患者を見失う」
家庭医にとっては当たり前のことを、WHO が世界の保健医療システムに対して言い直してくれた、と捉えると分かりやすい。

- 部品 : HbA1c, 血圧, eGFR, BMI 単独の数値
- 繋がり : 数値どうしの関係、数値と生活の関係、患者と家族の関係、患者と医療者の関係

転換 2: 処方から学習へ

これは「ガイドラインを捨てよう」という話ではない。
ガイドラインは " 最初の仮説 " として使い、次回外来は " 前回の仮説の検証 " に使う、というイメージ。

PDCA を、医療者だけでなく 患者と一緒に回す 感じ。

- 処方: 「こうしなさい」と告げるモード。プロトコル通り、ガイドライン通り
- 学習: 「やってみてどうだったか」を一緒に振り返るモード

転換 3: アウトカム測定から文脈理解へ

アウトカム測定をやめるわけではない。

測定で「何が起きたか」、文脈理解で「なぜ起きたか」を補う。どちらか一方では片手落ち。

- アウトカム測定：HbA1c が下がったか、再入院率が減ったか
- 文脈理解：なぜ下がったのか / なぜ下がらなかったのか、その人の生活の中で何が起きているか

3つの転換を、さっきの症例に当てはめると

転換	この症例での実装
部品→繋がり	HbA1c 単独でなく、配偶者入院・社会的孤立・通院困難の連鎖を見る
処方→学習	「散歩を再開しましょう」ではなく「次回までに何が起きたか教えてください」
測定→文脈	次回 HbA1c が下がっても上がっても、「なぜ？」を聞ける関係

Part 3. 自分の診療への適用

明日の外来で 1 つだけ試せること

外来の 1 人目の患者の最後に、こう聞いてみる：
「最近、生活で何か変わったことはありますか？」
ポイント：

- ・ カルテのキーワードを埋めるためではなく、繋がりを探すために 聞く
- ・ 返ってきた情報は、無理に問題リストに統合しなくていい。「気にしている」と相手に伝わるだけで十分
- ・ 慣れてきたら「家族で何か変化はありますか？」「仕事はどうですか？」とバリエーションを増やす

ふりかえりの型 — 自分の診療に学習ループを入れる

外来終わりに 30 秒、こう問う：

1. 今日の患者で、繋がりを見落としていた可能性があるのは誰か？
2. その繋がりは、次回どう聞けば浮かび上がりそうか？
3. 自分が気づけたのは、何のおかげだったか？

メモは要らない。考える習慣だけでいい。

これが WHO の言う「処方から学習へ」の、自分自身への適用。

Part 4. 次の半径へ — チームと外来導線

半径を広げる：チーム回診のシステム視点

チーム = 1 人の医師では見えない繋がりを束ねる装置

- ・カンファレンスで症例を出すとき、社会背景の 1 スライドを必ず付ける文化にできるか？
- ・看護師・MSW・薬剤師が見ている " 繋がり " は、医師が見ている " 部品 " を補完する宝の山
- ・「あの人の奥さん、最近来てないですね」という看護師の一言が、HbA1c の謎を解くことがある

外来導線を「学習ループ」に変える小さな仕掛け

どれも今日明日には変えられないかもしれない。

でも、「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

- 予約システムに「前回の宿題」欄を追加できないか
- 受付の問診票に「最近の変化」を書く欄を追加してみる
- 検査結果説明のとき、数値の前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番にする

Part 5. 自院・地域に持ち帰る

自分の診療所 / 病院をシステムとして見る

これらは、個人の努力不足ではなく、システムの構造の問題であることが多い。
システム思考は、こういう問いに「誰が悪い」ではなく「どこに繋がり of 詰まりがあるか」で答える道具を提供する。

- 「なぜうちの外来は毎週金曜の午後がパンクするのか」
- 「なぜリハビリ依頼の戻りが遅いのか」
- 「なぜ ACP の話し合いが一向に進まないのか」

マクロ文脈：2030 年に 1,100 万人不足の世界

「専門家から協働の促進者へ」という WHO の言葉は、
家庭医にとっては新しいアイデンティティではなく、
すでにやっていることに世界がやっと追いついてきた という話。

- WHO は「人を増やす」だけでは追いつかないと認めた
- だからこそ、既存の人材が 繋がり を束ねる 力を持つことが切実に必要
- 家庭医療・総合診療という職種は、まさにこの文脈の最前線にいる

今日のまとめ

1. WHO は 2026 年に 3 つのフレーム転換 を公式に打ち出した
(部品→繋がり / 処方→学習 / 測定→文脈)
2. それは 明日の外来の 1 問 から実装できる
(「最近、生活で変わったことは？」)
3. 半径を広げると、チーム → 外来導線 → 自院 → 地域 → 世界 の話になる
4. 家庭医療科にいる私たちは、この潮流の追い風 を受けている

明日からの宿題（任意）

うまくいかなくても OK。やってみて気づいたことを次回シェアしてください。それが「学習ループ」です。

- 1 人の患者で「繋がりを意識した 1 問」を試す
- カンファで症例を出すとき、社会背景の 1 行を必ず添える
- 外来終わりに 30 秒、「今日見落とした繋がりはなかったか」を自問する

出典

<<https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/02-02-2026-systems-thinking-for-health-systems-strengthening-changing-the-frame>>

<<https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/embracing-complexity--systems-thinking-for-health-workforce-strengthening>>

- ・ 主出典 : WHO/AHPSR. *Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame*. 2026 年 2 月 .
- ・ 副出典 : WHO. *Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce Strengthening (Webinar)*. 2026 年 1 月 27 日 .
- ・ 背景文献 : ドネラ・メドウズ『世界はシステムで動く』 , ピーター・センゲ『学習する組織』

参考：もう一步深めたい人へ

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。

- 複雑適応系 (Complex Adaptive System, CAS) の入門資料
- ドネラ・メドウズのレバレッジポイント論 (12 段階)
- WHO の保健システム 6 つのビルディングブロック
- 『Friday Night at the ER』 — システム思考教育用シミュレーションゲーム

Generated by Scribe / 2026-04-09 / 出典は必ず一次資料を確認してください

出典（主）

